Che cos'è la bioetica?

Le ragioni con cui decidiamo quando la tecnica incontra la vita

Materiale ad uso personale dello studente

Un centro di riabilitazione vuole introdurre un trattamento nuovo. È un caso immaginario: non gli attribuiamo una malattia precisa, percentuali di successo o rischi inventati. Sul tavolo c'è una proposta, e il centro deve capire se sia buona. La direzione vuole conoscere i risultati attesi. I professionisti chiedono quali prove li sostengano. Una persona invitata a ricevere il trattamento vuole capire che cosa le verrà fatto, per quale motivo e se potrà scegliere. Ciascuno sta ponendo una domanda necessaria. Ma quelle domande non sono tutte dello stesso tipo.

Una proposta ancora incompleta

Per sapere se un trattamento funziona servono osservazioni, studi e competenza medica. Non lo decidiamo per alzata di mano. Per sapere se sia giusto proporlo in un certo modo, invece, dobbiamo ragionare anche su chi ne riceve i benefici, chi ne sopporta i rischi e come viene coinvolto. Un risultato interessante non risponde da solo a tutto questo. Se lasciassimo una persona all'oscuro soltanto per ottenere più facilmente la sua collaborazione, avremmo un problema morale anche prima di sapere come andrà il trattamento.

Questo è il campo della bioetica. La parola mette insieme la vita e l'etica, cioè la riflessione su come agire bene. La bioetica esamina le scelte che riguardano la vita e la salute, quando intervengono la medicina, la ricerca e la tecnica. Il suo orizzonte comprende anche il mondo vivente e l'ambiente: gli interventi sulla vita possono avere effetti che superano il singolo paziente e il presente.

La medicina è dunque indispensabile alla bioetica. Senza dati attendibili rischieremmo di discutere di una cosa che non esiste. Ma i dati non scelgono da soli il fine per il quale usarli. I dati ci dicono che cosa può accadere; per decidere dobbiamo anche dire quale bene cerchiamo e per chi.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La parola e l'ampiezza della disciplina

Il riferimento di *bio-* è la vita; *etica* indica la riflessione sul bene dell'agire. Potter, un ricercatore legato alla riflessione sulla sopravvivenza e sul rapporto tra biologia e valori, usa *bioethics* nel titolo dell'articolo *Bioethics. The science of survival* nel 1970 e del libro *Bioethics. Bridge to the future* nel 1971. Il suo ponte collega la conoscenza dei viventi e i valori: senza valutare come usare le conoscenze, lo stesso progresso può minacciare la sopravvivenza. È una collaborazione fra saperi, non la sostituzione della scienza con un'opinione morale. La riflessione si allarga anche all'ecosistema e alle generazioni future; perciò la bioetica non coincide con il solo incontro medico-paziente: comprende professioni sanitarie, ricerca, salute pubblica e rapporti con l'ambiente.

Due ragioni per approvare

Torniamo al tavolo del centro. Qualcuno propone di confrontare le possibilità e scegliere quella che produce il maggiore beneficio complessivo, considerando anche le sofferenze e gli svantaggi. È il criterio dell'utilitarismo: si giudica l'azione soprattutto dal bilancio delle conseguenze per gli interessati. Non significa pensare soltanto ai soldi, né fare il proprio comodo. La sua domanda seria è come ottenere il maggior bene possibile con ciò che abbiamo. Se impieghiamo male le risorse, qualcuno potrebbe perdere un aiuto che sarebbe stato possibile offrirgli.

Un'altra persona risponde che, quando non condividiamo tutte le convinzioni morali, occorre cercare regole sulle quali gli interessati possano accordarsi. Il centro non dovrebbe imporre unilateralmente le proprie preferenze. Questa attenzione all'accordo è caratteristica del contrattualismo. Qui lo presentiamo nella forma del consenso fra soggetti capaci di decidere: la giustificazione passa attraverso un'intesa accettata. Non è semplicemente far vincere chi urla più forte. È cercare una base comune per agire anche tra persone che pensano diversamente.

Fermiamoci su che cosa riguarda questo accordo. Non stiamo ancora chiedendo al singolo paziente se accetti il trattamento per sé. Stiamo cercando su che cosa fondare le regole con cui il centro e gli interessati agiranno insieme. Per esempio, potrebbero accordarsi su questa regola: ogni proposta di trattamento deve essere spiegata in modo comprensibile a chi la riceve. Nella forma di contrattualismo considerata, quelle regole trovano la loro giustificazione nell'intesa fra chi partecipa. Il consenso del singolo a ricevere una cura riguarda invece la sua scelta personale. Le due questioni si incontrano, ma un accordo sulle regole non dimostra che ogni paziente abbia capito la proposta e l'abbia accettata.

Le due ragioni possono sostenere la stessa scelta. Un progetto potrebbe essere giudicato vantaggioso e, insieme, accettato dagli interessati. Ma non sono la stessa ragione. Se qualcuno non può partecipare all'accordo, basta che gli altri si siano intesi? Se il risultato complessivo è buono, come consideriamo chi riceve un danno? Queste domande non cancellano il valore delle conseguenze o del consenso. Chiedono se bastino a fondare il giudizio. Due persone possono approvare lo stesso progetto per ragioni diverse, e quelle ragioni contano quando il caso cambia.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Distinguere senza fare caricature

Il criterio utilitarista valuta le conseguenze, cerca di massimizzare il piacere e di ridurre la sofferenza; ne esistono varianti dell'atto e della regola. L'utile non si riduce al denaro, e non tutti gli utilitaristi arrivano alle stesse conclusioni. Considerare le conseguenze non rende da solo utilitarista un ragionamento: conta se esse assumono il ruolo decisivo nella giustificazione. Il personalista può confrontare rischi e benefici; non abbandona per questo il riferimento alla persona. Il contrattualismo è una famiglia più ampia della forma considerata qui, legata al consenso della comunità capace di decidere. La sua domanda è: come agire insieme quando non abbiamo tutte le medesime convinzioni? L'accordo sulle regole come fondamento dell'agire comune non coincide con il consenso del singolo paziente al trattamento, che riguarda la sua scelta informata. Un centro e gli interessati, per esempio, possono concordare una regola: ogni proposta di trattamento deve essere spiegata in modo comprensibile a chi la riceve. La regola condivisa non dimostra ancora che il singolo paziente abbia compreso e accettato quella proposta. La difficoltà riguarda la tutela di chi non partecipa all'accordo; non significa che qualunque teoria contrattualista escluda necessariamente i deboli. Il dato biomedico resta lo stesso: cambiano le ragioni addotte, non l'esito clinico.

Chi può prendere parte alla scelta

Un terzo modo di procedere cerca alcuni principi condivisibili con cui esaminare la proposta. Si chiama principialismo. Anziché affidare tutto a una sola domanda, ne tiene aperte quattro: la persona può scegliere? Si cerca il suo bene? Si evitano danni ingiustificati? Benefici e oneri sono distribuiti in modo giusto? Sono quattro esigenze da applicare al caso, motivando le scelte quando entrano in tensione. Non è una macchina che produce automaticamente una risposta.

Cominciamo dalla persona seduta al tavolo. Il principio di autonomia chiede di rispettare la sua capacità di decidere consapevolmente e senza costrizioni. Supponiamo, sempre dentro il nostro caso inventato, che la spiegazione del trattamento sia piena di termini che non capisce. La persona annuisce perché si vergogna di fermare chi parla. Quel cenno ci basta per dire che ha scelto davvero?

Il problema non si risolve sostituendoci a lei: decidiamo noi perché lei non capisce. Si comincia rendendo la spiegazione comprensibile, lasciando spazio alle domande e verificando che cosa abbia capito. L'autonomia non coincide con l'essere abbandonati a scegliere da soli. Un aiuto può renderla più effettiva. La competenza dei professionisti e la voce del paziente hanno compiti diversi, e occorrono entrambe.

Qui non abbiamo scoperto una sua incapacità: abbiamo descritto una spiegazione che non arriva a chi la ascolta. Per questo il primo lavoro riguarda il modo di comunicare. Se il centro controllasse soltanto di aver pronunciato tutte le informazioni, potrebbe considerare concluso il proprio compito mentre la persona rimane esclusa. Ascoltare che cosa ha capito permette invece di accorgersi del problema e di riprendere la spiegazione. L'aiuto sostiene la sua scelta proprio perché non ne decide in anticipo l'esito. Rispettare la scelta di una persona richiede di metterla in condizione di capire ciò che sta scegliendo.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Principialismo, autori e portata

Tom L. Beauchamp e James F. Childress pubblicano *Principles of Biomedical Ethics* nel 1979. Autonomia, beneficenza, non maleficenza e giustizia formano un linguaggio per esaminare problemi diversi. Le situazioni concrete possono richiedere un bilanciamento: non c'è un ordine meccanico valido per ogni caso. La critica di Sgreccia alla mancanza di un fondamento antropologico unitario è il giudizio di un autore personalista, non un'autodescrizione di Beauchamp e Childress. Il Rapporto Belmont e il libro dei due autori non sono lo stesso documento: il primo ha tre principi, il secondo quattro.

Bene, danni e distribuzione

La seconda domanda riguarda il bene. Beneficenza, in questo linguaggio, non significa fare un'offerta in denaro: significa agire a beneficio della persona. Nel nostro centro chiede quale miglioramento si cerchi e su quali ragioni si fondi la proposta. Il fatto che un trattamento sia nuovo non è già un beneficio, e neppure lo è il prestigio che potrebbe procurare alla struttura.

La non maleficenza chiede di non arrecare danni ingiustificati. È distinta dalla beneficenza: desiderare un risultato buono non elimina la necessità di considerare ciò che può andare male. Non stiamo affermando che ogni rischio vieti ogni intervento. Stiamo chiedendo di conoscere i rischi, di ridurli e di valutarli rispetto ai benefici attesi. Siccome non abbiamo dati sul trattamento immaginario, non possiamo dare per favorevole questo rapporto.

La giustizia apre infine lo sguardo oltre il singolo incontro. Il centro dispone di tempo, personale e risorse limitati. Come distribuisce l'accesso e gli impegni? Trattare giustamente non significa sempre dare a tutti una cosa identica: le necessità possono essere diverse. Significa poter giustificare le differenze con ragioni pertinenti, invece di favorire chi esercita più pressione o è più comodo da assistere.

I quattro principi si tengono presenti insieme. Un consenso non rende irrilevante un danno; un beneficio possibile non rende superflua l'informazione; una buona relazione con chi è già dentro il centro non esaurisce il problema di chi rimane fuori. Un progetto va giudicato anche dal bene che procura, dai danni che comporta e da come distribuisce benefici e oneri. Ma resta una domanda: perché quella persona merita rispetto anche quando non porta risultati utili o non riesce a far valere la propria voce?

I principi non sono un algoritmo

Beneficenza chiede di procurare il bene, non soltanto di volerlo; non maleficenza chiede di non arrecare danni ingiustificati. La beneficenza, nel lessico bioetico, non è una raccolta di offerte. Autonomia non è semplicemente lasciare firmare un foglio; l'informazione ha senso se permette di capire e scegliere. Giustizia non è distribuire sempre quantità identiche: le differenze possono essere giustificate da necessità diverse. Sgreccia rilegge questi principi nella propria impostazione personalista; la sua gerarchia non appartiene al principialismo. I principi non sono quattro indicatori numerici che, sommati, approvano un progetto.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Il valore di chi dipende

La proposta personalista parte proprio da qui. La persona non riceve il proprio valore dal fatto di essere utile, indipendente o capace di stipulare un accordo. È qualcuno per cui dobbiamo cercare il bene. Perciò la sua difficoltà nel capire, o il suo bisogno di aiuto, non la trasformano in una cosa disponibile. Nel personalismo la dignità appartiene alla persona per ciò che è, anche quando diminuiscono la salute o la capacità di scegliere.

Questa impostazione è presente nella bioetica cattolica e viene sviluppata nel personalismo di cui stiamo parlando. Non significa che soltanto un cattolico possa riconoscere la dignità umana. La Chiesa propone anche ragioni rivolte alla comprensione di tutti: se il valore di una persona dipendesse dall'efficienza del momento, diminuirebbe proprio quando quella persona ha più bisogno di protezione. La dignità indica invece una ragione per rispettarla che non cambia con la sua prestazione. [1]

La fede cristiana aggiunge il riconoscimento dell'essere umano come creatura voluta da Dio e il significato dell'incarnazione: il Figlio di Dio ha assunto la condizione umana, anche corporea. Il corpo malato non è quindi un involucro trascurabile rispetto a una parte più importante. La cura riguarda una persona intera. Questa è una ragione teologica del rispetto, non un dato ottenuto misurando l'efficacia di una terapia. [1]

Un documento della Chiesa lo formula così:

> *Per il solo fatto d'esistere, ogni essere umano deve essere pienamente rispettato.*
>
> Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Dignitas personae (2008), n. 8, p. 4 [2]

Nel nostro caso la frase impedisce di trattare chi fatica a capire come un ostacolo da aggirare. Il centro dovrà cercare un modo di coinvolgerlo e aiutarlo. La persona conserva valore anche se non riesce a rendere semplice il nostro lavoro.

Che cosa significa persona nel personalismo

Il personalismo può essere relazionale, ermeneutico e ontologico: qui si considera quest'ultimo, senza pretendere di esaurire tutti gli usi della parola. La persona vale per ciò che è e non soltanto per le scelte che riesce a compiere. L'unità corporea e spirituale impedisce di trattare il corpo come oggetto estrinseco alla persona. L'istruzione *Dignitas personae* della Congregazione per la Dottrina della Fede, al n. 8, esclude discriminazioni quanto alla dignità basate sullo sviluppo e sullo stato di salute; al n. 7 riconduce il rispetto alla creazione e all'incarnazione. Sono formulazioni dottrinali del Magistero cattolico; la sistemazione dei quattro principi personalisti in Sgreccia è una proposta filosofica e teologica coerente con quella dottrina, non un nuovo elenco di dogmi definito dalla Chiesa. Lo stesso documento, al n. 3, incoraggia la ricerca a servizio del bene integrale: la bioetica cattolica non si esaurisce in un'opposizione alla tecnica.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Vita e libertà non si separano

Prendere sul serio la persona richiede la difesa della vita fisica. Non significa ridurre tutto alla biologia: significa riconoscere che la vita corporea è la condizione nella quale quella persona può agire, incontrare gli altri e realizzare i propri progetti. Perciò merita cura e protezione; non diventa un materiale da usare perché altri possano raggiungere un risultato.

Questo riguarda anche libertà e responsabilità. Nel caso del centro, rispettare la libertà di chi riceve la proposta non significa far sparire la responsabilità di chi la offre. Il professionista deve poter spiegare che cosa sta proponendo e perché lo considera un bene. E la persona non viene ridotta al destinatario passivo di una decisione già presa.

La libertà è rispettata quando la persona può partecipare e quando chi propone la cura risponde del bene che le sta offrendo. Per il personalismo la libertà comporta una responsabilità verso la vita propria e altrui: poter scegliere non rende buona qualsiasi scelta. La vita corporea rende possibile anche l'esercizio della libertà; per questo chi sceglie e chi propone devono considerare il bene della persona di cui stanno parlando, ciascuno secondo la propria responsabilità.

Fondamentale non significa unico

La vita fisica è un valore fondamentale perché in essa la persona si manifesta, agisce e costruisce relazioni; questo non significa che il valore della persona si esaurisca nella vita biologica. La difesa della vita richiede anche promozione e assistenza: non è soltanto astenersi da un danno. Libertà e responsabilità sono legate: la responsabilità è del professionista e anche del paziente.

Un aiuto che lascia partecipare

Resta il modo di organizzare l'aiuto. Socialità significa riconoscere che la salute di ciascuno richiede anche la collaborazione degli altri: nessuno costruisce da solo tutte le competenze e le possibilità di cura di cui ha bisogno. Sussidiarietà significa dare il sostegno necessario senza cancellare ciò che la persona e le comunità possono fare. L'aiuto deve raggiungere chi ne ha più bisogno e sostenerne la partecipazione, non sostituirla per comodità.

Se il centro lascia la persona sola davanti a una spiegazione incomprensibile, le manca un aiuto. Se organizza tutto senza ascoltarla, le toglie uno spazio che potrebbe avere. La possibilità da cercare è accompagnarla perché possa prendere parte alla scelta. Organizzare l'aiuto significa rispondere al bisogno della persona e sostenerne la partecipazione possibile.

Il principio di totalità

Il principio di totalità, o terapeutico, riguarda l'intervento sulla parte malata o causa del male per salvaguardare l'organismo, e ha delle condizioni: assenza di altri mezzi adeguati, probabilità di riuscita proporzionata, consenso. Un esempio è l'asportazione dell'appendice, quando è necessaria alla salvaguardia dell'organismo. Il tutto è la persona, non la società: la persona non è una parte disponibile del corpo sociale.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

Organizzare il sostegno

Socialità è cooperazione per la vita e la salute di ciascuno; sussidiarietà è aiuto dove serve, senza soppiantare le iniziative libere. Da queste idee non si deduce un unico modello politico di sanità.

Che cosa manca alla decisione

Possiamo ora tornare alla proposta iniziale senza votare a intuito se il trattamento ci piaccia. Mancano dati attendibili: efficacia, rischi, alternative. Manca sapere come la persona verrà informata e ascoltata, e come il progetto peserà sugli altri. Sono mancanze diverse, che richiedono competenze diverse. Per questo la bioetica fa incontrare professionisti della salute, studiosi dell'etica e altre competenze: una persona sola non esaurisce tutte le domande.

Abbiamo anche imparato a riconoscere quattro ragioni: cercare il beneficio complessivo, fondare l'azione sull'accordo, confrontare più principi, partire dal valore della persona. Non sono quattro caselle dentro cui rinchiudere per sempre le persone. Chi ragiona da personalista considera anche le conseguenze e ascolta il consenso. Ciò che distingue i modelli è il modo in cui giustificano il giudizio, specialmente quando le esigenze si contrastano.

La risposta iniziale, dunque, non è che la tecnica sia nemica della vita. Una possibilità di cura può essere un bene da sviluppare. La domanda è a quali condizioni lo diventi per le persone coinvolte. Non abbiamo abbastanza elementi per approvare il trattamento inventato, ma sappiamo spiegare perché un semplice annuncio di successo non basterebbe. La bioetica chiede di spiegare e confrontare le ragioni delle scelte, perché una possibilità tecnica diventi una decisione responsabile.

Sedi del confronto, con date e limiti

I comitati sono luoghi di incontro fra competenze diverse sui problemi della vita e della salute. Il Comitato Nazionale per la Bioetica italiano è istituito il 28 marzo 1990: fra le sue finalità ci sono formulare pareri e promuovere informazione. Giovanni Paolo II istituisce la Pontificia Accademia per la Vita con *Vitae mysterium*, l'11 febbraio 1994. Il suo compito originario è studiare, informare e formare sui problemi biomedici e giuridici relativi alla promozione e difesa della vita, in rapporto alla morale cristiana e al Magistero. Istituzioni con mandati diversi non sono quattro scuole filosofiche trasformate in uffici: il loro compito non autorizza a confondere un parere, una legge e un insegnamento dottrinale.

Per lo studio

1. Perché conoscere l'efficacia di un trattamento non esaurisce la valutazione bioetica? Risposta: l'efficacia è un fatto da accertare; restano da giustificare il fine, il modo in cui si tratta la persona e la distribuzione di benefici e oneri.

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati

La bioetica valuta come usare le possibilità della medicina e delle scienze della vita, perché sapere che cosa possiamo fare non basta a stabilire che cosa sia bene fare alle persone e al mondo vivente.

Fonti

[1] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Dignitas personae (2008), nn. 3, 7–8, pp. 1–4

[2] Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione Dignitas personae (2008), n. 8, p. 4

© Matteo Sestili — Tutti i diritti riservati